MÓDULO 11 · IA PARA MEDICAL AFFAIRS

# Perplexity para la investigación del panorama

Perplexity se ha consolidado como una de las herramientas de referencia para investigación con citación de fuentes en tiempo real, una característica que la distingue especialmente de otros modelos de lenguaje generativo y que la hace particularmente valiosa para un MSL que necesita hacer una primera exploración amplia y actualizada de un tema, siempre con la posibilidad de verificar cada afirmación en su fuente original.

**PERPLEXITY**

- Investigación con citación de fuentes en tiempo real
- Útil para una primera exploración amplia y actualizada de un tema
- Cada afirmación puede verificarse en su fuente original

A diferencia de un modelo de lenguaje conversacional puro, Perplexity funciona combinando la generación de lenguaje con una búsqueda activa en internet en el momento de la consulta, y presenta sus respuestas acompañadas sistemáticamente de las fuentes concretas de las que extrae cada afirmación. Esta característica —citar de forma nativa y fiable, en lugar de generar referencias que después hay que verificar por separado— es, según comparativas recientes de herramientas de IA orientadas a investigación, uno de sus puntos fuertes más consistentes para trabajo académico, médico y analítico.

- Combina la generación de lenguaje con una búsqueda activa en internet
- Presenta cada afirmación junto a las fuentes concretas de las que la extrae
- Citar de forma nativa y fiable es uno de sus puntos fuertes más consistentes

Para un MSL, esto la convierte en una herramienta especialmente útil para el mapeo inicial del panorama (landscape research): explorar rápidamente qué se sabe hoy sobre un área terapéutica emergente, qué compañías tienen programas de desarrollo activos en una diana concreta, qué tendencias de tratamiento están ganando tracción en la comunidad clínica, o qué se ha publicado recientemente sobre un tema específico que aún no domina en profundidad. Es una forma eficiente de llegar preparado a una primera inmersión en un tema, con referencias concretas que después pueden profundizarse y verificarse en la fuente original —nunca aceptando el resumen de Perplexity como sustituto de la lectura del artículo original cuando la información va a comunicarse formalmente a un HCP—.

**USO: MAPEO DEL PANORAMA (LANDSCAPE RESEARCH)**

- Explorar un área terapéutica emergente, programas activos o tendencias de tratamiento
- Forma eficiente de llegar preparado a una primera inmersión en un tema
- Nunca aceptar el resumen como sustituto de leer el artículo original

Otra aplicación práctica es el seguimiento de actualidad científica y competitiva: usar Perplexity para preguntas del tipo "¿qué se ha publicado en las últimas semanas sobre X comparador en Y indicación?", aprovechando su capacidad de incorporar información reciente a través de la búsqueda activa, en lugar de depender únicamente del conocimiento estático con el que fue entrenado un modelo de lenguaje convencional.

- Seguimiento de actualidad científica y competitiva
- Incorpora información reciente mediante búsqueda activa
- Supera la dependencia del conocimiento estático de un modelo convencional

La disciplina de verificación sigue siendo indispensable: aunque Perplexity cita sus fuentes de forma más sistemática que otras herramientas, la calidad y fiabilidad de esas fuentes varía —puede incluir tanto publicaciones científicas revisadas por pares como contenido de menor rigor disponible públicamente en internet—, por lo que un MSL debe evaluar críticamente, con los mismos criterios de jerarquía de evidencia trabajados en el Módulo 6, la calidad de cada fuente citada antes de considerar fiable la información extraída, y nunca comunicar un dato clínico relevante a un HCP sin haber contrastado esa fuente original con el rigor que exige la comunicación científica no promocional.

**DISCIPLINA DE VERIFICACIÓN**

- La calidad y fiabilidad de las fuentes citadas varía considerablemente
- Evaluar cada fuente con los criterios de jerarquía de evidencia del Módulo 6
- Nunca comunicar un dato clínico a un HCP sin contrastar la fuente original